

**Diretoria de Assistência à Saúde–
Diretoria de Políticas de Saúde
Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial
Gerência de Regulação**

Nota Orientativa Conjunta nº 18/2025 – SES.DAS/DPS

Assunto: Protocolo de organização do cuidado e critérios para encaminhamento à Cirurgia Bariátrica na Rede de Atenção à Saúde (RAS) da pessoa com obesidade no Município de Joinville

Considerando a Portaria nº 252/GM/MS, de 19 de fevereiro de 2013, que institui a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando que a obesidade é uma condição crônica e um fator de risco para outras doenças e uma manifestação de insegurança alimentar e nutricional, acometendo a população em todas as fases da vida de forma crescente;

Considerando que a organização da RAS deve garantir cuidados integrais por meio da definição de funções de cada ponto de atenção, comunicação entre os serviços e oferta de recursos, através de ações de promoção e proteção da alimentação adequada e saudável que incluem a educação alimentar e nutricional e a melhoria da qualidade nutricional;

Considerando a necessidade de implementação da Linha de Cuidado de Atenção à Pessoa com Sobrepeso e Obesidade;

Considerando a necessidade de orientar os gestores, coordenadores e profissionais da RAS quanto à aplicação e operacionalização das diretrizes estabelecidas pelas Portarias do MS nº 424 que “Estabelece diretrizes para a organização da prevenção e do tratamento do sobrepeso e obesidade como linha de cuidado prioritária da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas”, e nº 425 que “Redefine as diretrizes para a organização da prevenção e do tratamento do sobrepeso e obesidade como linha de cuidado prioritária da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, ambas de 19 de março de 2013, e Portaria nº 62, de 06 de janeiro de

2017, que “Estabelece regulamento técnico, normas e critérios para o Serviço de Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade, com vistas ao aprimoramento da organização dos serviços, da gestão do cuidado e da alocação eficiente e planejada de recursos, de acordo com os princípios do SUS;

A Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial e a Gerência de Regulação, em parceria com o Serviço de Cirurgia Bariátrica - Obesimor do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt (HRHDS), vem por meio desta nota orientativa, orientar, padronizar e validar as orientações a serem seguidas pelas equipes da RAS para o cuidado integral ao usuário com sobrepeso e obesidade e critérios para encaminhamento à cirurgia bariátrica.

1. DIRETRIZES GERAIS PARA O TRATAMENTO CIRÚRGICO DA OBESIDADE

O tratamento cirúrgico é apenas uma parte do tratamento integral da obesidade, que é prioritariamente baseado na promoção da saúde e no cuidado clínico longitudinal.

Na organização da atenção ao portador de obesidade, a cirurgia bariátrica deve ser um recurso terapêutico oferecido com rigoroso critério pelo serviço de assistência de alta complexidade ao indivíduo com obesidade, após o insucesso em tratamentos anteriores, tantos no âmbito da Atenção Básica quanto na assistência especializada. A indicação e a regulação do acesso a este procedimento no SUS devem seguir as normas estabelecidas pelo Sistema de Regulação (SISREG).

2. CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO PARA CIRURGIA BARIÁTRICA

- Indivíduos que apresentem Índice de Massa Corpórea (IMC) $\geq 50 \text{ Kg/m}^2$;
- Indivíduos que apresentem IMC $\geq 40 \text{ Kg/m}^2$, com ou sem comorbidades, sem sucesso no tratamento clínico longitudinal realizado, na Atenção Básica e/ou serviço de assistência especializada ao indivíduo com obesidade, por no mínimo 02 (dois) anos e que tenham seguido protocolos clínicos;
- Indivíduos com IMC $\geq 35 \text{ kg/m}^2$ e com comorbidades, tais como pessoas com alto risco cardiovascular, Diabetes Mellitus e/ou Hipertensão Arterial Sistêmica de difícil controle, apneia do sono, doenças articulares degenerativas, sem sucesso no tratamento clínico longitudinal, realizado por no mínimo 02 (dois) anos e que tenham seguido protocolos clínicos, no âmbito da Atenção Básica ou na assistência especializada.

Considerações Etárias:

- Jovens (16-18 anos): poderá ser indicado o tratamento cirúrgico naqueles que apresentarem o Escore-Z maior que +4 na análise do IMC por idade. Contudo, salienta-se que o tratamento cirúrgico não deve ser realizado antes da consolidação das epífises de crescimento. A avaliação clínica do jovem necessita constar em prontuário e deve incluir: a análise da idade óssea e avaliação criteriosa do risco-benefício, realizada por equipe multiprofissional com participação de 02 (dois) profissionais médicos especialistas da área clínica e cirúrgica;
- Idosos (>65 anos): deverá ser realizada avaliação individual por equipe multiprofissional, considerando a avaliação criteriosa do risco-benefício, risco cirúrgico, presença de comorbidades, expectativa de vida e benefícios do emagrecimento.

3. ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)

A APS deve ser a porta de entrada do usuário com obesidade no SUS, sendo responsável pela coordenação do cuidado e pelo acompanhamento longitudinal compartilhado desse usuário com a assistência especializada, dentro da sua unidade de referência.

É responsabilidade da APS:

- A. Realizar a vigilância alimentar e nutricional da população adstrita a fim de estratificar o risco para o cuidado do sobrepeso e da obesidade;
- B. Realizar ações de promoção da saúde e prevenção do sobrepeso e da obesidade de forma intersetorial e com participação popular, respeitando hábitos e cultura locais, com ênfase nas ações de educação alimentar e estímulo a atividade física;
- C. Apoiar o autocuidado para manutenção e recuperação do peso saudável;
- D. Prestar assistência terapêutica multiprofissional (assistente social, enfermagem, farmacêutico, fisioterapia, médica, nutrição, psicologia, profissional de educação física, terapeuta ocupacional, técnicos/auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde) aos indivíduos adultos com sobrepeso e obesidade que apresentem IMC entre 25 e 40 kg/m², de acordo com as estratificações de risco e as diretrizes clínicas estabelecidas;



- E. Coordenar os cuidados e encaminhar para assistência especializada os indivíduos adultos que, esgotadas as possibilidades terapêuticas na Atenção Básica, necessitem de outros pontos de atenção, quando apresentarem IMC ≥ 35 kg/m² com comorbidades ou IMC ≥ 40 kg/m²;
- F. Dar continuidade a assistência terapêutica multiprofissional aos usuários que realizaram procedimento cirúrgico para tratamento da obesidade após o período de 18 meses de acompanhamento pós-operatório realizado no serviço de assistência de alta complexidade ao indivíduo com obesidade;
- G. Garantir o acolhimento adequado das pessoas com sobrepeso e obesidade na APS;
- H. Articular ações intersetoriais para promoção da saúde, de forma a apoiar os indivíduos, famílias e comunidade na adoção de modos de vida saudáveis que permitam a manutenção ou recuperação do peso saudável.

Importante:

As equipes da APS devem organizar um calendário de cuidado programático para usuários com sobrepeso e obesidade, com base nos critérios de classificação do IMC, conforme orientações técnicas vigentes e Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para sobrepeso e obesidade em adultos (Brasil, 2020). O cuidado integral deve ser ofertado por meio de atendimentos individuais, Visitas Domiciliares, Matriciamento, Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) e atividades coletivas, contando com o apoio das equipes multiprofissionais. Essas estratégias visam garantir um cuidado contínuo, resolutivo e centrado nas necessidades do usuário.

4. REGULAÇÃO DO ACESSO

Os encaminhamentos para assistência à alta complexidade deverão ser realizados pelo médico assistente da unidade de referência, inserindo o usuário em fila de regulação no Sistema Integrado de Gestão (SIG-SaudeTech), e selecionando o **Procedimento 99000715 – Consulta em Cirurgia Bariátrica Obesidade (PMV)**, com descrição detalhada do quadro clínico, Classificação Internacional de Doenças (CID) que justifique o encaminhamento, resultados de exames prévios relacionados (quando necessário) ou avaliações complementares e o procedimento terapêutico medicamentoso iniciado ou em curso, para justificar o encaminhamento e a solicitação de avaliação na assistência alta complexidade, com base na classificação dos critérios de risco deste protocolo.



Após o encaminhamento, o médico regulador responsável avalia se o usuário atende aos critérios de indicação para a cirurgia bariátrica, e insere os mesmos no SISREG estadual, devolvendo os usuários que não atendem aos critérios estabelecidos à unidade de origem, com a solicitação de informações complementares.

Nota: Os documentos com orientações referentes ao monitoramento, controle e acompanhamento do “Painel de Regulação” no Sistema SIG-SaudeTech do Município de Joinville, assim como o POP SES.DAS/DPS nº 47 - "Como Monitorar o Painel de Regulação - Pedidos bloqueados pelo médico regulador no Sistema Integrado de Gestão (SIG-SaudeTech)", estão disponíveis no processo do Sistema Eletrônico de Informação - SEI Nº 24.0.007275-7.

5. ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ALTA COMPLEXIDADE

A atenção especializada e o serviço de alta complexidade ao indivíduo com obesidade é ofertada pelo Serviço de Cirurgia Bariátrica - Obesimor, vinculado ao HRHDS, que por meio da regulação estadual, atende usuários encaminhados pelos 13 municípios das Regionais de Saúde Nordeste e Vale do Itapocu.

O Serviço de Cirurgia Bariátrica - Obesimor é responsável por prestar assistência terapêutica multiprofissional durante o pré e pós-operatório no tratamento cirúrgico da obesidade grau III e grau II com comorbidades, garantindo a continuidade do tratamento por equipe multiprofissional até 18 meses após o procedimento.

É responsabilidade do Serviço de Cirurgia Bariátrica - Obesimor:

- A.** Organizar o acesso à cirurgia, considerando e priorizando os indivíduos que apresentam outras comorbidades associadas à obesidade e/ou maior risco à saúde;
- B.** Realizar tratamento cirúrgico da obesidade de acordo com o estabelecido nas diretrizes clínicas gerais dispostas no Anexo I da Portaria nº 424/2013 e normas de credenciamento e habilitação definidas pelo Ministério da Saúde em atos normativos específicos;
- C.** Realizar cirurgia plástica reparadora para indivíduos submetidos ao tratamento cirúrgico da obesidade, conforme critérios dispostos em atos normativos específicos do Ministério da Saúde;

- D.** Garantir assistência terapêutica multiprofissional pós-operatória aos usuários que realizaram procedimento cirúrgico para tratamento da obesidade por 18 meses no serviço de assistência de alta complexidade ao indivíduo com obesidade;
- E.** Prestar assistência terapêutica multiprofissional pré-operatória aos usuários com indicação de realização de procedimento cirúrgico para tratamento da obesidade;
- F.** Organizar o retorno dos usuários para a Atenção Básica e realizar a contrarreferência para a unidade de referência do usuário, comunicando as equipes de saúde responsáveis acerca dos usuários em acompanhamento;
- G.** Para usuários residentes fora de Joinville, cabe ao Serviço de Cirurgia Bariátrica - Obesimor, comunicar periodicamente os municípios responsáveis acerca dos usuários que estão em acompanhamento.



REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 62, de 6 de janeiro de 2017**. Estabelece diretrizes para a organização da prevenção e do tratamento do sobrepeso e obesidade como linha de cuidado prioritária da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, n. 4, p. 36, 9 jan. 2017. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt0062_06_01_2017.html. Acesso em: 8 maio 2025;

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 424, de 19 de março de 2013**. Redefine as diretrizes para a organização da prevenção e do tratamento do sobrepeso e obesidade como linha de cuidado prioritária da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, n. 54, p. 63, 20 mar. 2013. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0424_19_03_2013.html. Acesso em: 8 maio 2025;

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 425, de 19 de março de 2013**. Estabelece regulamento técnico, normas e critérios para o Serviço de Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade. *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, n. 54, p. 64, 20 mar. 2013. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0425_19_03_2013.html. Acesso em: 8 maio 2025;

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Orientações para a coleta e análise de dados antropométricos em serviços de saúde: norma técnica do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN**. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 76 p. (Série G. Estatística e Informação em Saúde). ISBN 978-85-334-1813-4. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/orientacoes_coleta_analise_dados_antropometricos.pdf. Acesso em: 8 maio 2025;

BRASIL. Ministério da Saúde. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas: sobrepeso e obesidade em adultos**. Brasília: Ministério da Saúde, 2020. 100 p. Disponível em: https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/20201113_pcdt_sobrepeso_e_obesidade_em_adultos_29_10_2020_final.pdf. Acesso em: 8 maio 2025;

BRASIL. Ministério da Saúde. Universidade Federal de Minas Gerais. **Instrutivo de abordagem individual para o manejo da obesidade no SUS**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. 192 p. ISBN 978-65-5993-604-5. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/instrutivo_abordagem_manejo_obesidade_sus.pdf. Acesso em: 8 maio 2025;

CEMBRANEL, Francieli; ZONTA, Ronaldo. **Abordagem do sobrepeso e obesidade na**

atenção primária em saúde. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2018. 100 p. Disponível em: https://unasus-cp.moodle.ufsc.br/pluginfile.php/189126/mod_resource/content/32/moodleface/livro.pdf. Acesso em: 8 maio 2025;

SANTA CATARINA. Prefeitura de Joinville. Secretaria da Saúde de Joinville. Diretoria de Assistência à Saúde. Sistema Eletrônico de Informação - SEI. **Manual da Equipe Multiprofissional na Atenção Primária à Saúde.** Joinville - SC: 2023.

